



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

LAPORAN TRIWULAN

II

KOMITE PPRA

BULAN APRIL - JUNI

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya penyusunan Laporan Triwulan II Pengendalian Pencegahan Resistensi Antimikroba tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu sehingga dapat dilaporkan kepada Dewan Pengawas dan Pemilik Rumah Sakit Prima Husada (PT. Disa Prima Medika).

Pengendalian Pencegahan Resistensi Antimikroba dilakukan berdasarkan tersedianya data audit penggunaan antibiotik. Data yang tersedia yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Kedua data tersebut saling berkesinambungan untuk dapat menilai apakah penggunaan antibiotik Rumah Sakit sudah tergolong rasional atau tidak. Hasil audit kuantitatif dan kualitatif dapat dijadikan penilaian terhadap seluruh SMF terkait pemberian antibiotik didasarkan pada PPAB (Panduan Penggunaan Antibiotik).

Dengan tersusunnya Laporan Pengendalian Pencegahan Resistensi Antimikroba ini, kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah membantu terselesaikannya laporan ini sehingga dapat dipergunakan untuk pendekatan sistemik dalam hal aplikasi proses dan pengetahuan yang seragam dalam melaksanakan semua kegiatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit.

Penyusun

I. SDM

Jumlah SDM bulan ini:

Jabatan	Jumlah SDM			Ket.
	Standar	April – Juni	Kebutuhan	
Ketua PPRA	1	1	0	
Sekretaris	1	1	0	
Anggota	31	30	1	

II. Pemenuhan kualifikasi SDM:

Jabatan	Nama	Pendidikan		Pelatihan	Keterangan
		Standar	Kondisi saat ini		
Ketua	dr. Dicky Faturrachman, Sp. A., M. Biomed.	S1	Sp 1 pediatrik	Pelatihan PPRA eksternal	Belum terlaksana
Sekretaris	apt. Rifdah Bunga K S.Farm.	S1	Apoteker	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
Anggota	dr. Ari Putriani, Sp.PK	S1	Dokter Patologi Klinik	Pelatihan PPRA eksternal	Terlaksana
	dr. Arief Heru Wicaksono, Sp.An	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	dr. Ardhi Bustami, Sp. PD	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	dr. Adhya Aji Pratama, Sp. PD	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Belum Terlaksana
	dr. Antonius Setiadi, Sp. B	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	dr. Iwan Donosepoetro, Sp. B.FINACS	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana

dr. Sigit Wahyu Jatmiko, Sp. BP-RE	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Heriyatmo, Sp.Pd	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Ira Setya, Sp. JP	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Dewi Maharani, Sp. S	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Titok, Sp. M	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Aida M., Sp. OG	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Andy, Sp. P	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Pradana Nurhadi, Sp. U	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Arianto, Sp. OT	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Miftakhul Huda, Sp. KJ	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
drg. Bhakti Prasetyo D, Sp. Ort	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Nimim , Sp. KK	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Naufal Fraid Dwi Rendragraha	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Rino R.	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana

	dr. Nur Mazidah	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	apt. Yuanita Eka L, S.Farm	S1	Apoteker	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	apt. Asharul Fahrizi, S.Farm	S1	Apoteker	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	apt. Ica Anindya Pangestika, S.Farm	S1	Apoteker	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	apt. Guspa Gayatri A, S.Farm	S1	Apoteker	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	apt. Fadilah Maulana Ihram A, S.Farm	S1	Apoteker	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	ns. Very Susanto, S. Kep	S1	S1 Ners	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	ns. Siti Durotul Ibadiyah, S. Kep	S1	S1 Ners	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	Puput Sekar Nari Ratih, Amd. Kep	S1/D3	Bidan	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	Sherly Rosita, Amd. Kep.	S1/D3	Perawat	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	Trikaya Inggar Yuniar, Amd. Kep	S1/D3	Perawat	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana

III. PROGRAM KERJA DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN

No	Kegiatan Pokok	Hasil	Ket.
1	Pembuatan Pedoman Penggunaan Antibiotika RS	Tidak ada pembaharuan Pedoman Penggunaan Antibiotik (PPAB)	Pedoman penggunaan antibiotik yang ada masih relevan untuk digunakan
2	Sosialisasi PPRA	Meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan tentang PPRA tahun 2025	
3	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Antibiotika	Rapat untuk membahas tentang pengumpulan data penggunaan antibiotika di RS Prima Husada	Laporan triwulan

IV. FASILITAS

No	Kegiatan Pokok	Ket.
1	Ruang Komite PPRA	Mengajukan ke pihak manajemen, belum ada realisasi

V. INDIKATOR MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN PPRA

No	Indikator Mutu	Standar
1	Surveilans penggunaan antibiotika secara keseluruhan di RS Prima Husada	-
2	Audit penggunaan antibiotika secara kualitatif (Gyssens)	≥50%
3	Surveilans pola kuman dan kepekaan antibiotika tahun 2020	-
4	Audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif	-

VI. PENCAPAIAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN PPRA TRIWULAN II

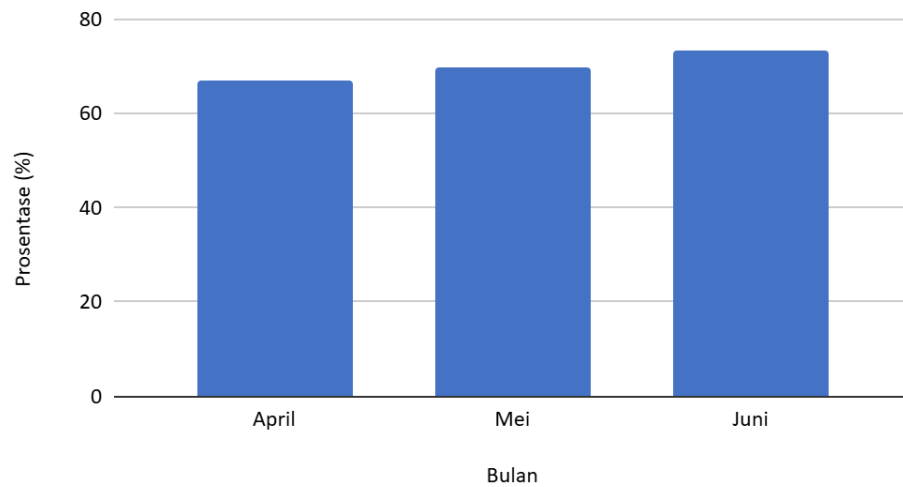
1. Surveilans penggunaan antibiotika secara keseluruhan di RS Prima Husada

a. Tabel Surveilans penggunaan antibiotik secara keseluruhan di RS Prima Husada

No	Bulan	Prosentase (%)
1	April	66,85
2	Mei	69,74
3	Juni	73,45

b. Grafik surveilans penggunaan antibiotik secara keseluruhan di RS Prima Husada

Surveilans Penggunaan Antibiotik



c. Analisa surveilans penggunaan antibiotik secara keseluruhan di RS Prima Husada

- Penggunaan antibiotik tertinggi pada bulan Juni sebesar 73,45 %, pada bulan Mei sebesar 69,74 %, dan pada bulan April sebesar 66,85 %.
- Belum ada target atau standar penggunaan antibiotik di Rumah Sakit.
- Pengambilan data berdasarkan SIMRS.

2. Audit penggunaan antibiotika secara kualitatif (Gyssens)

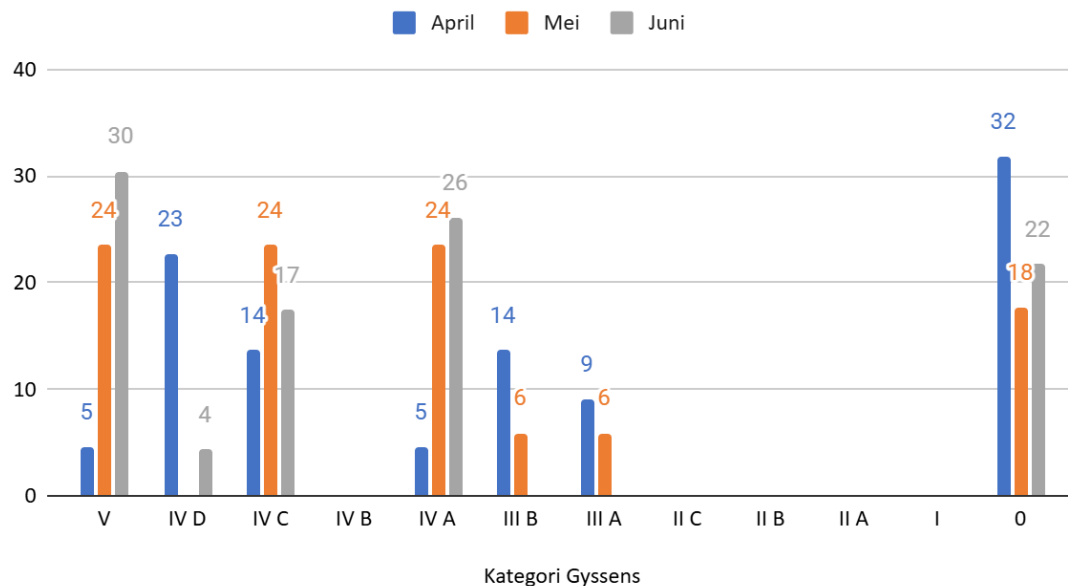
a. SMF Bedah

- Tabel audit penggunaan antibiotika SMF Bedah secara kualitatif (Gyssens)

NO	Kategori Gyssens	Jumlah (%)		
		April	Mei	Juni
1.	Kategori V	5	24	30
2.	Kategori IV D	23	0	4
3.	Kategori IV C	14	24	17
4.	Kategori IV B	0	0	0
5.	Kategori IV A	5	24	26
6.	Kategori III B	14	6	0
7.	Kategori III A	9	6	0
8.	Kategori II C	0	0	0
9.	Kategori II B	0	0	0
10.	Kategori II A	0	0	0
11.	Kategori I	0	0	0
12.	Kategori 0	32	18	22
Total		100	100	100

- Grafik audit penggunaan antibiotik SMF Bedah secara kualitatif (Gyssens)

SMF BEDAH



- Analisa penggunaan antibiotika secara kualitatif (Gyssens)

- Pada triwulan II, terdapat kategori 0 yaitu penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase kategori 0 tertinggi pada SMF Bedah terdapat pada bulan April sebesar 32%. Namun, masih belum ada persentase dari ketiga bulan tersebut yang memenuhi standar.

-
2. Kategori III A tertinggi pada SMF Bedah dengan prosentase sebesar 9% dibulan April yang menunjukkan durasi pemberian antibiotik terlalu lama.
 3. Kategori III B terdapat pada SMF Bedah. Prosentase tertinggi terdapat pada bulan April sebesar 14% yang menunjukkan durasi pemberian antibiotik terlalu singkat.
 4. Kategori IV A tertinggi pada SMF Bedah dengan prosentase sebesar 26% dibulan Juni yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih efektif.
 5. Kategori IV C paling tinggi terdapat pada SMF Bedah sebesar 24% dibulan Mei yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena terdapat antibiotik lain yang lebih murah.
 6. Kategori IV D paling tinggi terdapat pada SMF Bedah sebesar 23% dibulan April yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya.
 7. Kategori V terdapat pada SMF Bedah sebesar 30% dibulan Juni yang menunjukkan adanya pemberian antibiotik namun tidak ada indikasi.
- Rencana tindak lanjut

Untuk SMF Bedah, persentase Gyssens kategori V (Pemberian antibiotik tanpa indikasi) masih termasuk cukup tinggi. Begitu juga dengan kategori Gyssens kategori 0 (Pemberian antibiotik tepat dan rasional) yang persentasenya masih belum memenuhi standar, sehingga perlu dukungan manajemen melalui komite medis untuk melakukan supervisi dan sosialisasi terkait penggunaan antibiotik yang bijak dan rasional.

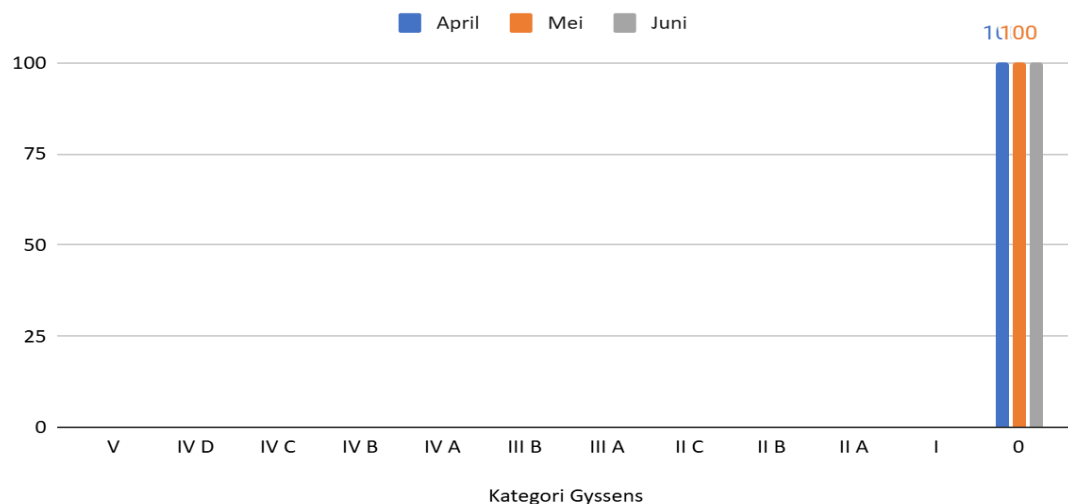
b. SMF Obgyn

- Tabel audit penggunaan antibiotika SMF Obgyn secara kualitatif (Gyssens)

NO	Kategori Gyssens	Jumlah (%)		
		April	Mei	Juni
1.	Kategori V	0	0	0
2.	Kategori IV D	0	0	0
3.	Kategori IV C	0	0	0
4.	Kategori IV B	0	0	0
5.	Kategori IV A	0	0	0
6.	Kategori III B	0	0	0
7.	Kategori III A	0	0	0
8.	Kategori II C	0	0	0
9.	Kategori II B	0	0	0
10.	Kategori II A	0	0	0
11.	Kategori I	0	0	0
12.	Kategori 0	100	100	100
Total		100	100	100

- Grafik audit penggunaan antibiotik SMF Obgyn secara kualitatif (Gyssens)

SMF OBGYN



- Analisa penggunaan antibiotik secara kualitatif (Gyssens)

Pada SMF Obgyn hanya terdapat kategori 0 yang menunjukkan penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase kategori 0 pada SMF Obgyn yaitu 100% disetiap bulannya. Hasil tersebut sudah sesuai dengan standart yaitu perolehan persentase kategori 0 $\geq$ 50%.

- Rencana tindak lanjut

Pada SMF Obgyn, persentase Gyssens kategori 0 sudah mencapai 100%, maka

perlu dipertahankan.

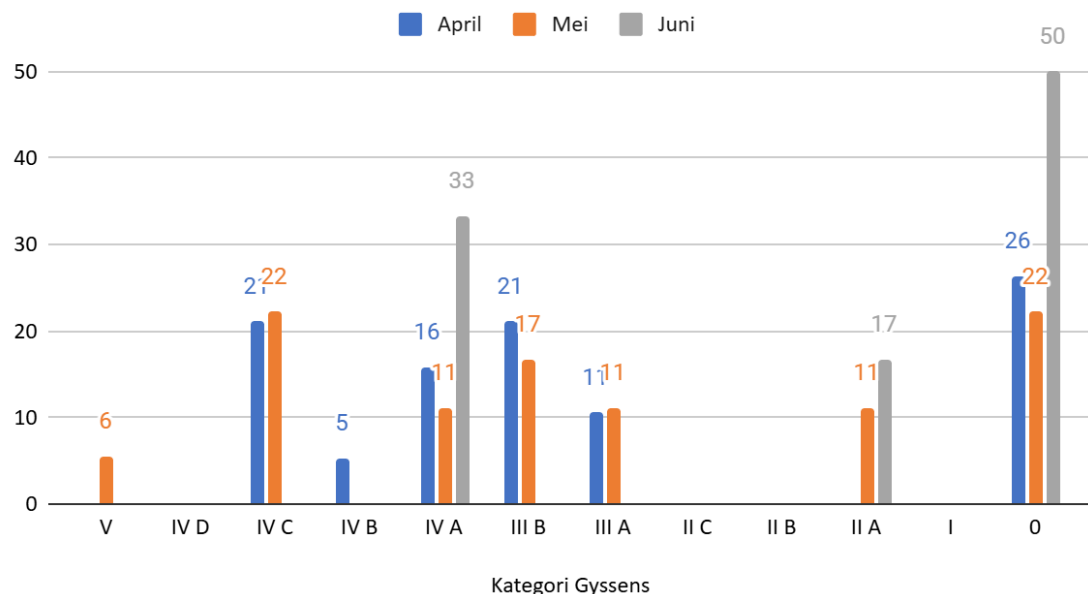
c. SMF IPD, Paru, Jantung dan Syaraf

- Tabel audit penggunaan antibiotika SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung secara kualitatif (Gyssens)

NO	Kategori Gyssens	Jumlah (%)		
		April	Mei	Juni
1.	Kategori V	0	6	0
2.	Kategori IV D	0	0	0
3.	Kategori IV C	21	22	0
4.	Kategori IV B	5	0	0
5.	Kategori IV A	16	11	33
6.	Kategori III B	21	17	0
7.	Kategori III A	11	11	0
8.	Kategori II C	0	0	0
9.	Kategori II B	0	0	0
10.	Kategori II A	0	11	17
11.	Kategori I	0	0	0
12.	Kategori 0	26	22	50
Total		100	100	100

d. Grafik audit antibiotik SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung secara kualitatif (Gyssens)

SMF IPD, PARU, SYARAF, JANTUNG



e. Analisa penggunaan antibiotika secara kualitatif (Gyssens)

1. Pada triwulan II terdapat kategori 0 yaitu penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase kategori 0 tertinggi terdapat pada bulan Juni sebesar 50%.
2. Kategori II A terdapat pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung. Prosentase tertinggi

terdapat pada bulan Juni sebesar 17% yang menunjukkan dosis pemberian antibiotik tidak tepat.

3. Kategori III A tertinggi pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung dengan prosentase sebesar 11% dibulan April dan Mei yang menunjukkan durasi pemberian antibiotik terlalu lama.
 4. Kategori III B terdapat pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung. Prosentase tertinggi terdapat pada bulan April sebesar 21% yang menunjukkan durasi pemberian antibiotik terlalu singkat.
 5. Kategori IV A tertinggi pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung dibulan juni dengan prosentase sebesar 33% yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih efektif.
 6. Kategori IV B terdapat pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung sebesar 5% dibulan April yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya.
 7. Kategori IV C paling tinggi terdapat pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung sebesar 22% dibulan Mei yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena terdapat antibiotik lain yang lebih murah.
 8. Kategori V terdapat pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung sebesar 6% dibulan Mei yang menunjukkan adanya pemberian antibiotik namun tidak ada indikasi.
- Rencana tindak lanjut

Untuk SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung, persentase Gyssens kategori 0 (Pemberian antibiotik bijak dan rasional) pada bulan Juni telah mencapai standar. Untuk persentase Gyssens kategori V (Pemberian antibiotik tanpa indikasi) hanya terjadi pada bulan Mei dan dengan persentase yang terbilang kecil, maka perlu dipertahankan serta ditingkatkan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan penggunaan antibiotik rasional, maka perlu dilakukan PDSA sebagai berikut :

PLAN	DO	STUDY	ACTION
1. Meningkatkan persepsian antibiotik rasional >50%. 2. Meningkatkan kepatuhan DPJP terhadap PPAB dengan cara : • Melakukan sosialisasi secara rutin dan terus-menerus • Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan antibiotik rasional oleh tim PPRA.	1. Mengamati pelanggaran DPJP terhadap PPAB 2. Menelusuri penyebab terjadinya pelanggaran tersebut dengan pendekatan secara personal.	DPJP diajak berdiskusi untuk membentuk PPAB yang sesuai dengan PPK yang betul-betul disepakati.	Meningkatkan kepatuhan DPJP terhadap PPAB dengan cara : 1. melakukan sosialisasi secara rutin dan terus menerus.

3. Surveilans pola kuman dan kepekaan antibiotika tahun 2025

Surveilans pola kuman dan kepekaan antibiotika tahun 2025 masih dalam proses pengajuan pembuatan pola kuman.

4. Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif Triwulan I Tahun 2025

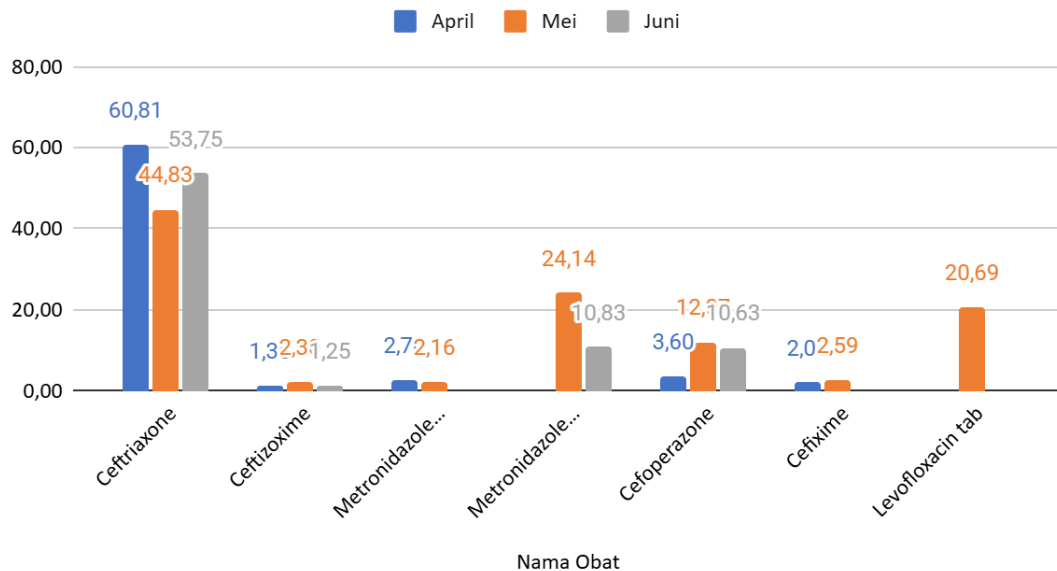
a. SMF Bedah

- Tabel perhitungan antibiotik pada SMF bedah secara kuantitatif

No	Nama obat	Bulan (DDD/100)		
		April	Mei	Juni
1.	Ceftriaxone	60,81	44,83	53,75
2.	Ceftizoxime	1,35	2,30	1,25
3.	Metronidazole tab	2,70	2,16	0
4.	Metronidazole inf	0	24,14	10,83
5.	Cefoperazone	3,60	12,07	10,63
6.	Cefixime	2,03	2,59	0
7.	Levofloxacin tab	0	20,69	0

- Grafik penggunaan antibiotik pada SMF bedah secara kuantitatif

DDD/100 HARI RAWAT INAP SMF BEDAH



- Analisa audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif pada SMF bedah

Penggunaan antibiotik pada triwulan II tahun 2025 oleh SMF Bedah terdiri dari Ceftriaxone, Ceftizoxime, Metronidazole po, Metronidazole inf, Cefoperazone, Cefixime dan Levofloxacin po. Antibiotik yang paling banyak digunakan oleh SMF bedah adalah antibiotik Ceftriaxone. Nilai tertinggi terdapat di bulan April sebesar 60,81 DDD/100 hari rawat inap. Hasil tersebut dapat dikaitkan dengan pemberian Ceftriaxone sebagai terapi empiris pada kebanyakan diagnosis infeksi di RS Prima Husada malang.

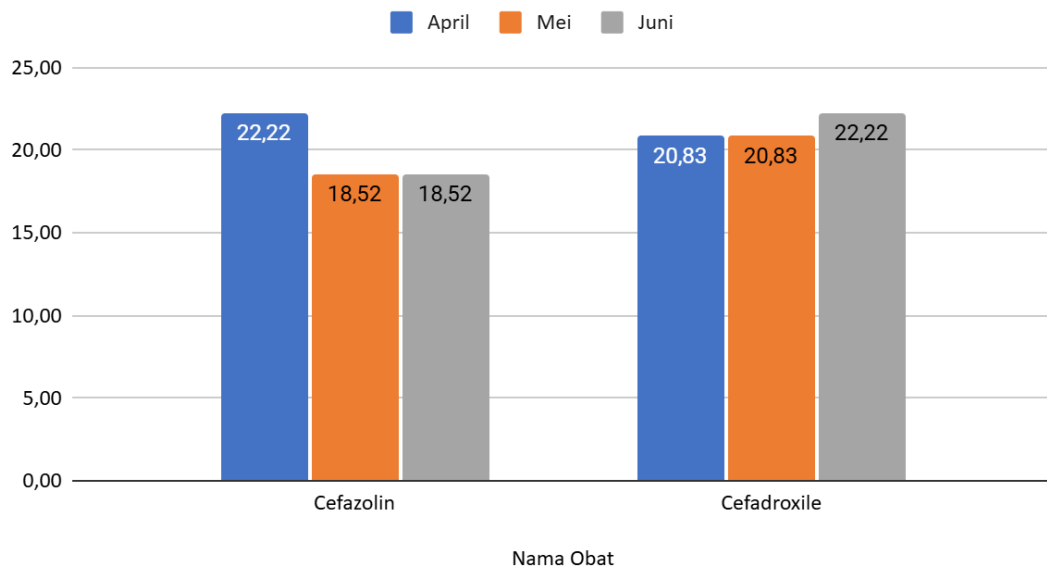
b. SMF Obgyn

- Tabel perhitungan antibiotik pada SMF Obgyn secara kuantitatif

No	Nama obat	Bulan (DDD/100)		
		April	Mei	Juni
1.	Cefazolin	22,22	18,52	18,52
2.	Cefadroxile	20,83	20,83	22,22

- Grafik penggunaan antibiotik pada SMF Obgyn

DDD/100 HARI RAWAT INAP SMF OBGYN



- Analisa audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif pada SMF Obgyn

Penggunaan antibiotik pada SMF Obgyn terdiri dari Cefazolin dan Cefadroxile. Antibiotik yang paling banyak di gunakan pada SMF Obgyn adalah antibiotik Cefadroxile dan Cefazoline. Nilai DDD/100 Cefazoline tertinggi terdapat pada bulan April sebesar 22,22 DDD/100 hari rawat inap. Sedangkan Nilai DDD/100 Cefadroxile tertinggi terdapat pada bulan Juni sebesar 22,22 DDD/100 hari rawat inap

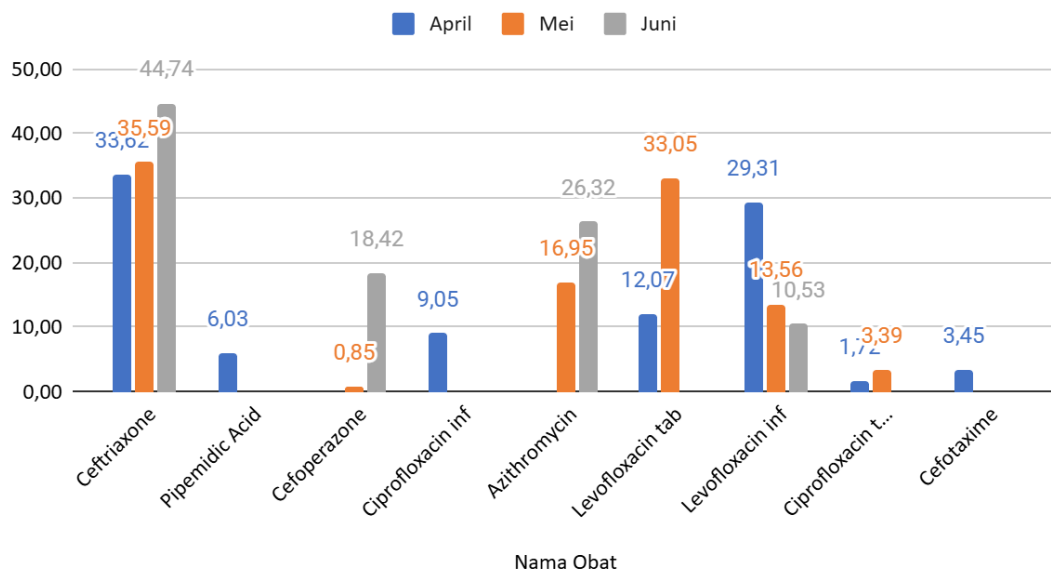
c. SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung

- Tabel perhitungan antibiotik pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung

No	Nama obat	Bulan (DDD/100)		
		April	Mei	Juni
1.	Ceftriaxone	33,62	35,59	44,74
2.	Pipemidic Acid	6,03	0	0
3.	Cefoperazone	0	0,85	18,42
4.	Ciprofloxacin inf	9,05	0	0
5.	Azithromycin	0	16,95	26,32
6.	Levofloxacin tab	12,07	33,05	0
7.	Levofloxacin inf	29,31	13,56	10,53
8.	Ciprofloxacin tab	1,72	3,39	0
9.	Cefotaxime	3,45	0	0

- Grafik penggunaan antibiotik pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung

DDD/100 HARI RAWAT INAP SMF IPD PARU, JANTUNG, SYARAF



- Analisa audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif pada SMF IPD, Paru, Syaraf, Jantung

Penggunaan antibiotik oleh SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung pada triwulan II terdiri dari 9 macam antibiotik. Antibiotik yang paling banyak di gunakan pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung adalah antibiotik Ceftriaxone. Nilai tertinggi penggunaan Ceftriaxoen terdapat dibulan Juni dengan nilai 44,74 DDD/100 hari rawat inap.

VII. KESIMPULAN

1. Surveilans penggunaan antibiotika secara keseluruhan di RS Prima Husada pada triwulan II tahun 2025 paling banyak terjadi pada bulan juni yakni sebesar 65.33 %.
2. Penggunaan antibiotik tepat dan rasional yang memenuhi target pada setiap bulan dalam pelaporan triwulan II hanya pada SMF Obgyn. Untuk SMF SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung penggunaan antibiotik tepat dan rasional yang memenuhi target hanya di bulan Juni.
3. Surveilans pola kuman dan kepekaan antibiotik 2025 masih dalam proses pengajuan pembuatan pola kuman.
4. Penggunaan antibiotik terbanyak oleh SMF Bedah dan SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung pada triwulan II tahun 2025 adalah antibiotik ceftriaxone sebesar 60,81; 44,74 DDD/100 hari rawat inap. Sedangkan pada SMF Obgyn antibiotik yang paling banyak di gunakan adalah Cefadroxile dan Cefazoline dengan nilai 22.22 DDD/100 hari rawat inap.

Malang, 02 Juli 2025

Penyusun,
Ketua Komite PPRA



dr. Dicky Faturrachman, Sp. A., M. Biomed.

Mengetahui,
Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah